

Dio Valsartan

Film Coated Tablets



Composition:

Each Dio Valsartan 80/5 Film Coated Tablet contains:
Valsartan 80 mg and Amlodipine (as besylate) 5 mg.
Each Dio Valsartan 160/5 Film Coated Tablet contains:
Valsartan 160 mg and Amlodipine (as besylate) 5 mg.
Each Dio Valsartan 160/10 Film Coated Tablet contains:
Valsartan 160 mg and Amlodipine (as besylate) 10 mg.

Mechanism of Action:

Valsartan: Is an angiotensin II receptors antagonist. Angiotensin II is a substance in the body that causes vasoconstriction, thus causing blood pressure to increase. Valsartan work by blocking the effect of angiotensin II on its receptors (AT1). As a result, blood vessels relax, and blood pressure is lowered.

Amlodipine: belongs to a class of medications called calcium channel blockers. The mechanism of the antihypertensive action is due to a direct relaxant effect on vascular smooth muscle, causing reductions in peripheral blood vascular resistance and in blood pressure. This combination has an additive antihypertensive effect, reducing blood pressure to a greater degree than either component alone.

Pharmacokinetics:

Valsartan: After giving valsartan orally, it reaches the peak of the plasma concentration after 2-4 hours. With a bioavailability of about 23%. Valsartan is highly bound to serum proteins (94-97) %, mainly albumin. Valsartan is not biotransformed to a high extent (as only about 20% of dose is recovered as metabolites). Valsartan is primarily eliminated by biliary excretion in faeces (about 83% of dose) and renally in urine (about 13% of dose), mainly as unchanged drug.

Amlodipine: After oral administration, amlodipine is well absorbed with peak blood levels between 6-12 hours post dose. Absolute bioavailability has been estimated to be between (64-80)%. Approximately 97.5% of circulating amlodipine is bound to plasma proteins. It is extensively metabolized in the liver to inactive metabolites, 10% of the parent compound and 60% of the metabolites of amlodipine are excreted in the urine.

Indications:

Dio Valsartan is used to treatment of essential hypertension. This combination is indicated in adult patients whose blood pressure has not been adequately controlled when valsartan or amlodipine is used as monotherapy.

Contraindications:

- Hypersensitivity to valsartan, amlodipine or to any of the other ingredients of the product.
- Haemodynamically unstable heart failure after acute myocardial infarction.
- Severe hepatic impairment, biliary cirrhosis and cholestasis.
- Obstruction of the outflow tract of the left ventricle (e.g.; hypertrophic obstructive cardiomyopathy and high-grade aortic stenosis).

Warnings & Precautions:

- In some cases, symptomatic hypotension may occur after initiation of therapy with Dio Valsartan.
- Dio Valsartan should not be used to treat high blood pressure in patients with unilateral or bilateral renal artery stenosis or renal artery stenosis in patients with one kidney.
- Patients with primary hyperaldosteronism should not be treated with Dio Valsartan as their renin angiotensin system is not activated.
- Amlodipine should be used with caution in patients with congestive heart failure.
- In patients with mild to moderate hepatic impairment without cholestasis, Dio Valsartan should be used with caution.
- Angioedema: Dio Valsartan should be immediately discontinued in patients who develop angioedema, and Dio Valsartan should not be re-administered.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: Pregnancy category D. Dio Valsartan is contraindicated in pregnancy.

Lactation: There is no information available regarding the use of Dio Valsartan during breastfeeding, therefore it is not recommended and alternative therapies with proven safety profiles are best preferred during breastfeeding, especially while breastfeeding a newborn or premature.

Drug Interactions:

Interactions linked to amlodipine:

- CYP3A4 inhibitors (e.g.; azole antifungals, macrolides, grapefruit): may give rise to significant increase in concentration amlodipine, resulting in increased blood pressure lowering effects.
- CYP3A4 inducers (e.g.; carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, rifampicin): Blood pressure and dose evaluation should be monitored regularly both during and after concomitant use of these drugs.
- Simvastatin: It is recommended to limit the dose of simvastatin to 20 mg daily in patients on amlodipine.

Interactions linked to valsartan:

- Potassium-sparing diuretics, potassium supplements: Monitoring of potassium plasma levels is advised.
- NSAIDs: When administered simultaneously, it can reduce the antihypertensive effect of Valsartan and increase serum potassium.
- Rifampicin, Ciclosporin, ritonavir: These medicines may increase the concentration of valsartan in the blood.
- The concomitant use of Valsartan with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment (GFR less than 60 ml/min/1.73 m²).

Side Effects:

- Common side effects: Hypokalemia, nasopharyngitis, influenza, headache, asthenia, fatigue, facial oedema, flushing, hot flush, oedema peripheral.
- Uncommon side effects: Anorexia, hypercalcaemia, hyperlipidaemia, hyperuricaemia, hyponatraemia, dizziness, paraesthesia, somnolence, visual impairment, vertigo, palpitations, tachycardia, orthostatic hypotension, cough, abdominal discomfort, nausea, and back pain.
- Rare side effects: Hypersensitivity, anxiety, tinnitus, syncope hyper-

hidrosis and polyuria.

Driving & Using Machines:

Patients should consider that dizziness or weariness may occasionally occur. If patients suffer from this adverse effects the ability to react may be impaired.

Dosage & Administration:

- The recommended dose is one Dio Valsartan tablet once daily. It is recommended to adjust the dose according to each patient's condition. Up to a maximum dose of 320/10.
- Treatment with Dio Valsartan may be used in patients whose blood pressure is not adequately controlled by monotherapy (valsartan alone or amlodipine alone).
- The antihypertensive effect is substantially present within 2 weeks after initiation of treatment. In most patients, maximal effects are observed within 4 weeks.

Renal impairment: No dosage adjustment is required mild or moderate renal impairment. Monitoring of potassium levels and creatinine is advised in moderate renal impairment.

Hepatic impairment: Dio Valsartan is contraindicated in patients with severe hepatic impairment. In patients with mild to moderate hepatic impairment without cholestasis, the maximum recommended dose is 80 mg valsartan.

Children: There are no data available to demonstrate the safety and efficacy of Dio Valsartan in children under 18 years of age.

Overdose:

Symptoms: There is no experience of overdose with Dio Valsartan. The major symptoms of overdose with valsartan is possibly pronounced hypotension with dizziness. Overdose with amlodipine may result in excessive peripheral vasodilation and, possibly, reflex tachycardia.

Treatment: If the drug has been taken recently, induction of vomiting or gastric lavage may be considered. Administration of activated charcoal up to two hours after ingestion of amlodipine has been shown to significantly decrease its absorption. Frequent monitoring of cardiac and respiratory system function and elevation of extremities should be done. A vasoconstrictor may be helpful in restoring blood pressure. Intravenous administration of calcium gluconate may reverse the calcium channel blocking effects. Both valsartan and amlodipine are unlikely to be removed by hemodialysis.

Storage:

Keep out of reach of children. Store below 30 °C.

Packaging:

Each Dio Valsartan (80/5) - (160/5) - (160/10) carton box contains 20 Film Coated Tablets in two Alu/Alu strips.

-A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctors prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICINES OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers- Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria

كل مضغوطة يو فالسارتان ٥/٨٠ ملتبسة بالفيلم تحتوي على:
 فالسارتان ٨٠ ملغ واملوديبين (على شكل بيسيلات) ٥ ملغ.
 كل مضغوطة يو فالسارتان ٥/١٦٠ ملتبسة بالفيلم تحتوي على:
 فالسارتان ١٦٠ ملغ واملوديبين (على شكل بيسيلات) ٥ ملغ.
 كل مضغوطة يو فالسارتان ١٠/١٦٠ ملتبسة بالفيلم تحتوي على:
 فالسارتان ١٦٠ ملغ واملوديبين (على شكل بيسيلات) ١٠ ملغ.

آلية التأثير:

فلساراتان: بعد إعطاء الفللساراتان عن طريق الفم، يصل إلى ذروة التركزب البلازما بعد ٠.٢ ساعات. ويتوافر حيوي حوالي ٢٣٪. يرتبط الفللساراتان بشكل كبير ببروتينات المصل (٩٧.٩٤٪) وبشكل أساسي الألبومين. ولا يخضع الفللساراتان للاستقلاب بنسبة عالية (يطرح ٢٠٪ فقط من الجرعة على شكل مستقلابات). يُفترَح القسم الأكبر منه عن طريق الإطراح الصفراوي في البراز (حوالي ٨٣ ٪ من الجرعة) وعن طريق الكلية في البول (حوالي ١٣٪ من الجرعة)، وبشكل أساسي كدواء غير متغير.

يستعمل ديو فالسارتان لمعالجة ارتفاع ضغط الدم الأساسي. تُستطب هذه المشاركة عند المرضى البالغين الذين لم يتم ضبط ضغط الدم لديهم بشكل كافٍ عند استخدام الفالسارتان أو الأملوديبين كعلاج مفرد.

- القصور القلبية غير المستقر ديناميكياً بعد احتشاء العضلة القلبية الحاد.
- القصور البطني الحاد، التليف البطني، الصفراوي، الزكود الصفراوي.
- انسداد مجرى تدفق البطين الأيسر (مثل اعتلال عضلة القلب الانسدادي الضخامي وتضيق الأبهر على الدرجة).

في بعض الحالات قد يحدث انخفاض ضغط دم عرضي بعد بدء العلاج بديو السارتان.

لا يجب علاج المرضى الذين يعانون من فرط الألدوستيرونية الأولي باستخدام فينوفاليرات لأن جملة نظام رينين أنجيوتنسين تكون غير فعالة. يجب استخدام أملوبيبين بحذر لدى المرضى الذين يعانون من قصور القلب الاحتقاني.

الحمل والإرضاع:

التداخلات الدوائية:

• محفّرات أنزيمات CYP3A4 (مثل كاربامازيبين، فينوباربیتال، فينيتوین، فيغاميبيسين): يجب مراقبة ضغط الدّم وتقييم الجرعة بانتظام على حدّ سواء أثناء وبعد استعمال هذه الأدوية بشكل متزامن.

• سيففاستاتين: يوصى بالحدّ من جرعة سيففاستاتين إلى ۲۰ ملغ يوميّاً لدى لمرضى الذين يتناولون ألوّلدیپين.

الاستخدام المتزامن للفالسارتان مع المنتجات الحاوية على الأليسكيرين مضاد
 ستطباب عند المرضى الذين يعانون من الداء السكري أو القصور الكلوي (معدل
 الترشيح الكبيبي أقل من ٦٠ مل / دقيقة / ١,٧٣ م^٢).

سعال، انزعاج بطني، غثيان، ألم في الظهر.

القيادة واستخدام الآلات:

الجرعة والاستعمال:

• يلاحظ التأثير الحافض لضغط الدم بشكل كبير في غضون أسبوعين بعد بدء المعالجة. لوحظ التأثيرات القسوى عند معظم المرضى في غضون ٤ أسابيع.

القصور الكلوي: لا يلزم تعديل الجرعة للمرضى الذين يعانون من قصور كلوي خفيف أو متوسط. ينصح بمراقبة مستويات البوتاسيوم والكرياتينين في القصور الكلوي المعتدل.

الأعراض: لا يوجد معلومات حول فرط الجرعة لـ ديو فالساراتان. الأعراض الرئيسية المحتملة للجرعة الزائدة من الفالساراتان هي انخفاض ضغط الدم مع النوبة. قد تؤدي الجرعة الزائدة من الألوموديدين إلى توسع الأوعية المحيطية المفرط، وربما حدوث تسرع قلب انعكاسي.

الحفظ:

التَّعْبَةُ:

كُلَّ عبوة كرتونية من ديو فالسارتان (٥/٨٠) - (٥/١٦٠) - (١٠/١٦٠) تحتوي على ٢٠ مضغوة ملتبسة بالفيلم ضمن شريطين Alu/Alu.

يستحضر يؤثر على مسكنه واستعماله خلافاً لتعليمات يحرصه للخطر
صفة الطيب وطريقة الاستعمال المتخصص عليها وتعليمات الصيدني
رفها لك ، فالتطبيق الصيدني هذا الخيار في الدواء وينفعه ويحرم
التكرار صرف الدواء بدون وصفة طبية
لا تترك الادوية بمقتضى ايدي الأطفال
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدانة العرب